

Il Corpo Sessuato — Sintesi

Salute Mentale · Sessione 10

La sessualità è molto più del sesso: è identità, relazione, storia culturale e diagnostica. Questa lezione mette in fila tutto — dalle definizioni alle parafilie — ed è piuttosto densa per l'esame. Tieniti forte.

Che cos'è la sessualità

- **OMS:** aspetto centrale dell'essere umano per tutto l'arco della vita; comprende sesso, identità di genere, orientamento sessuale, erotismo, piacere, intimità, riproduzione.
 - Influenzata da fattori biologici, psicologici, sociali, culturali, giuridici, storici, religiosi.
 - **Galimberti (prospettiva psicoanalitica):** la sessualità ha bisogno dell'altro — evolve insieme ai processi relazionali; parte dalla relazione madre-bambino; non è solo riproduzione ma costruzione dell'identità e delle relazioni.
-

Körper e Leib (Husserl)

- **Körper** → corpo come oggetto, anatomico, privo di soggettività
 - **Leib** → corpo vissuto, relazionale, aperto al mondo
 - Chiave per capire le parafilie: nelle parafilie il corpo altrui viene vissuto come Körper, non come Leib
-

Storia della sessuologia (da sapere per l'esame)

Chi	Opera	Anno	Contributo
Krafft-Ebing	Psychopathia Sexualis	1886	Primo catalogo scientifico; introduce il vocabolario (sadismo, masochismo, feticismo)
Freud	Tre saggi sulla teoria sessuale	1905	Sessualità infantile; fasi psicosessuali; deviazioni per oggetto e per meta
Kinsey	Rapporto Kinsey	anni '40-'50	Studio su 18.000 persone; svela discrepanza tra comportamento reale e pubblicamente accettato
Masters & Johnson	Human Sexual Response	1966	Studio sperimentale della risposta sessuale; ciclo della risposta sessuale

Finalità della sessualità (Grazzottin)

- **Amorosa** — sentimenti, intimità, connessione
- **Ricreativa** — piacere, desiderio, divertimento
- **Procreativa** — desiderio di un figlio
- **Strumentale** — per ottenere vantaggi personali, relazionali o oggettuali → disfunzionale se arreca danno a sé o ad altri

Identità sessuale: 4 dimensioni

1. **Sesso biologico** — caratteristiche fisiche (AFAB/AMAB); include intersex (~1,7%)
2. **Identità di genere** — sensazione intima di sentirsi uomo, donna o altro; può essere fluida
3. **Ruolo di genere** — aspettative sociali e culturali associate al genere

4. **Orientamento sessuale** — direzione dell'attrazione affettiva/romantica/sessuale
5. *(Espressione di genere — come ci si mostra al mondo)*

Termini chiave: **cisgender** (allineato), **transgender** (non allineato), **gender fluid**, **agender**.

Bisogno vs. desiderio e snodi di Lalli

- **Bisogno** → richiede soddisfazione immediata (neonato)
- **Desiderio** → la gratificazione può essere differita; è un passaggio evolutivo fondamentale
- Se il desiderio regredisce a bisogno → compulsività → base delle parafilie

6 snodi di Lalli (non superati = terreno per le parafilie):

Snodo	Se non risolto
Umanizzazione	Disumanizzazione — l'altro è un oggetto
Dipendenza → autonomia	Si resta oggetto nella relazione
Bisogno → desiderio	Compulsività, passaggio all'atto
Riconoscimento reciproco	Eliminazione dell'altro
Fantasia	Ripetitività compulsiva
Rapporto con l'altro	Relazione finta e teatrale

DSM-5: tre categorie per la sessualità

1. **Disfunzioni sessuali** — non trattate nel seminario
 2. **Disforia di genere**
 3. **Disturbi parafilici**
-

Disforia di genere

- Prima: "Disturbo dell'identità di genere" → ora: "Disforia di genere"
- L'accento si sposta sulla **sofferenza**, non sulla condizione
- **Essere transgender ≠ avere disforia di genere** — la diagnosi richiede sofferenza clinicamente significativa
- Serve diagnosi psichiatrica per accedere a terapia ormonale o riattribuzione chirurgica

Criteri DSM: - **Criterio A:** incongruenza marcata tra genere esperito e assegnato (≥6 mesi) + almeno **2** dei 6 criteri specifici - **Criterio B:** sofferenza clinicamente significativa o compromissione del funzionamento

Nei bambini: 8 criteri specifici, almeno 6 presenti + criterio B.

Parallelo omosessualità: nel DSM-I (1952) era nei disturbi sociopatici; nel DSM-II era come pedofilia; rimossa dall'OMS solo nel 1992.

Parafilia vs. disturbo parafilico

- **Parafilia** → interesse sessuale intenso e persistente verso qualcosa di non convenzionale (oggetti, situazioni, partner non standard)
 - **Disturbo parafilico** → parafilia che causa disagio personale O che per essere soddisfatta arreca/rischia di arrecare danno
 - La parafilia è condizione **necessaria ma non sufficiente** per il disturbo
 - Ogni disturbo: **Criterio A** (natura della parafilia) + **Criterio B** (conseguenze negative)
 - Solo con entrambi i criteri → diagnosi
-

I disturbi parafilici del DSM-5

Disturbo	Caratteristica
Voyeuristico	

Disturbo	Caratteristica
	Osservare persone ignare nude o in attività sessuali; eccitazione dalla segretezza
Esibizionistico	Mostrare i genitali a estranei non consenzienti; eccitazione dalla sorpresa altrui
Pedofilico	Impulsi sessuali verso bambini prepuberi; progetto lucido (non compulsivo)
Feticistico	Eccitazione legata a oggetti inanimati o parti del corpo non genitali
Da travestitismo	Impulso a travestirsi con abiti del sesso opposto (non confondere con identità trans)
Da masochismo sessuale	Eccitazione dall'essere umiliato/legato/fatto soffrire; variante: asfissiofilia
Da sadismo sessuale	Eccitazione dall'infliggere sofferenza ad altri
Frotteuristico	Eccitazione dal toccare/strusciare contro persone non consenzienti (luoghi affollati)

Da ricordare: - Körper vs. Leib — il corpo come oggetto vs. il corpo vissuto: è la chiave per leggere le parafilie - **Parafilìa ≠ disturbo parafilico** — la distinzione entra all'esame, anche come vignetta clinica - **Disforia di genere ≠ essere transgender** — la sofferenza è il criterio diagnostico, non la condizione